UVB

Azienda USL Val di Bisenzio
Ospedale San Lucchese del Bisenzio
U.O.C. Laboratorio Analisi e Microbiologia
Centro per la Diagnosi delle Emoglobinopatie
Direttore: Dott. Niccolò Magherini

Via del Mandorlo 18
59100 Prato
Accettazione 0574 802 310
Fax 0574 802 399
laboratorio@uslbisenzio.example.it

REFERTO DI LABORATORIO - SCREENING DEL PRIMO TRIMESTRE

Percorso nascita: esami della gravidanza (DPCM 12/01/2017) e screening emoglobinopatie di coppia

DATI DEL PAZIENTE

Cognome / Nome:	**DELA CRUZ MARICEL**
Nata il / a:	**09/08/1994, Quezon City (Filippine)**
Età / sesso:	**32 anni / F**
Cittadinanza:	**filippina**
Residenza:	**Via Pistoiese 211, 59100 Prato**
Telefono / e-mail:	**+39 351 447 2086 maricel.dc94@mail.example.it**
Professione:	**assistente familiare**
Documento:	**permesso di soggiorno n. I09482215**
Medico richiedente:	**Dott. Lapo Guarducci - Consultorio Familiare Prato Est**
MMG:	**Dott. Alessandro Biagini**

N. accettazione:	PR-26-1018442
Cod. anagrafico:	AN0429931
NRE:	090A41003318472
Prescrizione del:	29/09/2026
Prelievo:	06/10/2026 ore 7:52
Prelevatore:	inf. Elisa Cecchi
Ultima mestruazione:	18/07/2026
Referto parziale:	09/10/2026
Referto definitivo:	12/10/2026

Provetta tappo viola (K2-EDTA): 1018442-01

Codice fiscale D L C M C L 9 4 M 4 9 Z 2 1 6 J

Tessera sanitaria 8 0 3 8 0 1 9 0 9 9 0 9 8 8 4 2 0 0 6 4

EMATOLOGIA

Morfologia eritrocitaria allo striscio (Irene Becagli, TSLB): microcitosi, ipocromia, rari target cells; non schistociti.

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Globuli rossi (RBC)	5,28	10^6/µL	3,80 - 5,00	H
Emoglobina	10,4	g/dL	11,0 - 14,0 (gravidanza)	L
Ematocrito	33,6	%	33,0 - 42,0	
MCV	63,7	fL	80,0 - 98,0	L
MCH	19,7	pg	27,0 - 33,0	L
RDW-CV	14,9	%	11,5 - 14,5	H
Globuli bianchi (WBC)	8,94	10^3/µL	4,00 - 11,00	
Piastrine	238	10^3/µL	150 - 400	
VES (metodo Westergren mod.)	36	mm/h	< 25 (gravidanza < 40)	

IMMUNOEMATOLOGIA

Esame	Risultato	Metodo	Note
Gruppo AB0 e fattore Rh(D)	B Rh(D) positivo	microcolonna	doppia determinazione su due campioni
Test di Coombs indiretto	negativo, assenza di alloanticorpi	microcolonna LISS	da ripetere alla 28a settimana
Antigene Kell	K negativo	microcolonna	-

CHIMICA CLINICA ED ENDOCRINOLOGIA

TSH superiore al limite del primo trimestre con anti-TPO positivi: quadro di autoimmunità tiroidea tipo Hashimoto, segnalato al curante (vedi nota 3).

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Glucosio (a digiuno)	84	mg/dL	60 - 91 (gravidanza)	
Creatinina	0,52	mg/dL	0,45 - 0,90	
ALT	23	U/L	< 35	
Ferritina	48	ng/mL	15 - 150	
TSH reflex	2,86	mUI/L	0,10 - 2,50 (I trim.)	H

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
FT4	11,2	pg/mL	9,0 - 17,0	
Anticorpi anti-tireoperossidasi	156	UI/mL	< 34	**H**

SIEROLOGIA INFETTIVA

Siero tappo giallo 1018442-02; test di conferma eseguiti dal TSLB Marco Ciampolini.

Esame	Risultato	Cut-off / unità	Interpretazione
Toxoplasma IgG Toxoplasma IgM	0,8 0,21	< 1,6 UI/mL < 0,55 index	non immune (suscettibile): ripetere ogni 30-40 giorni
Rosolia IgG	42,7	> 10 UI/mL	immune (protetta)
Citomegalovirus IgG Citomegalovirus IgM	118 0,30	> 14 UA/mL < 0,70 index	pregressa infezione; avidità non necessaria
HIV 1-2 Ag/Ab combo	non reattivo (0,19)	S/CO < 1,00	-
Treponema pallidum Ab totali (CLIA)	negativo (0,06)	S/CO < 1,00	VDRL non eseguita
Anti-HCV	non reattivo (0,11)	S/CO < 1,00	-
HBsAg (CMIA)	**REATTIVO 4.812**	S/CO < 1,00	confermato con test di neutralizzazione
HBeAg / anti-HBe	negativo / positivo	-	infezione cronica da HBV HBeAg-negativa
Anti-HBc totali / IgM	positivo / negativo	-	esclusa infezione acuta
Anti-HDV	negativo (0,31)	-	eseguito su richiesta del laboratorio

VIROLOGIA MOLECOLARE

Esame	Risultato	U.M.	Limite di rilevazione	Note
HBV DNA quantitativo (real-time PCR)	1.420	UI/mL	10 UI/mL	log 3,15; carica bassa

COMUNICAZIONE URGENTE - Positività HBsAg in gravidanza. Il risultato è stato comunicato telefonicamente il 09/10/2026 alle ore 11:20 dalla Dott.ssa Serena Fantappiè all'ostetrica Benedetta Nesti del Consultorio Familiare Prato Est, che ha convocato la sig.ra Dela Cruz. Al parto il neonato dovrà ricevere immunoglobuline specifiche e prima dose di vaccino anti-epatite B entro 12 ore (segnalazione al Punto Nascita, prot. PN-2026-118204).

URINE

Esame urine	Risultato	Rif.
Peso specifico	1.021	1.005-1.030
pH	6,0	5,0-8,0
Proteine	< 10 mg/dL	assenti
Glucosio	tracce	assente
Leucociti esterasi	75 leu/µL	neg.
Nitriti	negativi	neg.
Sedimento	6-8 leucociti/campo	0-5

Urinocoltura (campione 1018442-05, mitto intermedio): Streptococcus agalactiae (gruppo B) 50.000 UFC/mL. Colorazione di Gram: cocchi gram-positivi in catenelle. Batteriuria da streptococco di gruppo B: indicazione a profilassi antibiotica intrapartum, indipendentemente dal tampone vagino-rettale.

Antibiotico	MIC (mg/L)	Interpr.
Penicillina	0,064	S
Ampicillina	0,125	S
Eritromicina	> 4	R
Clindamicina	> 1	R
Vancomicina	0,5	S

SCREENING PRENATALE COMBINATO (TEST BITEST)

Ecografia NT del:	08/10/2026	Ecografista:	Dott. Lapo Guarducci	Certificazione FMF:	n. FMF-208817
CRL:	48,6 mm	Translucenza nucale:	1,4 mm	Peso materno:	57 kg

Cut-off di rischio aumentato 1:300. Calcolo con software certificato; età gestazionale da CRL 11 settimane + 5 giorni alla data dell'ecografia.

Parametro	Valore	MoM	Rischio a priori (età)	Rischio combinato
PAPP-A	2,91 mUI/mL	1,12	-	-
free beta-hCG	38,4 ng/mL	0,86	-	-
Trisomia 21 (sindrome di Down)	-	-	1:420	**1:6.800** basso rischio
Trisomie 18 e 13	-	-	1:1.050	1:> 20.000 basso rischio

EMOGLOBINOPATIE - SCREENING DI COPPIA

In presenza di microcitosi con ferritina normale e HbA2 non aumentata è stata eseguita, su richiesta del Dott. L. Guarducci, l'analisi molecolare dei geni alfa-globinici sulla gestante e, contestualmente, lo screening del partner, sig. Rodel Bautista, nato a Cebu (Filippine) il 14/02/1990, C.F. BTSRDL90B14Z216N, prelevato il 07/10/2026 (acc. PR-26-1018795, NRE 090A41003318520).

Analisi molecolare n. EMG-26-0331 e EMG-26-0332, eseguita dalla Dott.ssa Ilaria Baldanzi; DNA conservato con codice DNA-EMG-26-0331.

Esame	M. Dela Cruz	R. Bautista	Valori di riferimento
Emoglobina (g/dL)	10,4	13,9	F 11,0 - 14,0; M 13,5 - 17,5
MCV (fL)	63,7	72,4	80,0 - 98,0
MCH (pg)	19,7	23,1	27,0 - 33,0
HbA2 (HPLC)	2,0 %	2,3 %	2,4 - 3,4 %
HbF (HPLC)	0,6 %	0,4 %	< 1,0 %
Corpi inclusi HbH	rari (1/1.000 GR)	non rilevati	assenti
Ferritina (ng/mL)	48	112	15 - 300
Geni alfa-globinici (gap-PCR, MLPA)	--SEA/alfa alfa (delezione SEA in eterozigosi)	-alfa3.7/alfa alfa (delezione 3.7 kb in eterozigosi)	alfa alfa/alfa alfa

Interpretazione

La gestante è portatrice di alfa-talassemia di tipo alfa-zero (--SEA); il partner è portatore di alfa-talassemia di tipo alfa-più (-alfa3.7). La coppia presenta un rischio riproduttivo del 25% per ogni gravidanza di un feto con malattia da HbH (--SEA/-alfa3.7), forma di talassemia intermedia di gravità variabile. La combinazione a rischio di idrope fetale da Hb Bart's (--/--) non è possibile con i genotipi riscontrati. Si raccomanda consulenza genetica urgente presso la SOD Genetica Medica (Dott. Bernardo Lastrucci), già prenotata per il 15 ottobre 2026, per la discussione della diagnosi prenatale su villi coriali. Si suggerisce lo studio del primo figlio della coppia, Angel Bautista (nato il 21/05/2021), sia per lo stato di portatore sia per HBsAg e anti-HBs.

COMUNICAZIONI E PRESA IN CARICO

Data	Destinatario	Contenuto	Operatore
09/10/2026	Ost. B. Nesti, Consultorio Prato Est	HBsAg reattivo, telefonata	Dott.ssa S. Fantappiè
10/10/2026	Ambulatorio di Epatologia, Dott.ssa Ludovica Pecchioli	invio per stadiazione HBV (elastografia, HBV DNA a 3 mesi)	Dott. Duccio Bencini
11/10/2026	SOD Genetica Medica, Dott. B. Lastrucci	esito screening di coppia emoglobinopatie	Dott.ssa I. Baldanzi
12/10/2026	U.O. Ostetricia - Punto Nascita	profilassi neonatale HBV; GBS positivo	Dott.ssa S. Fantappiè

La sig.ra Maricel Dela Cruz ha ritirato il referto parziale accompagnata dal compagno, sig. Bautista, e da una mediatrice linguistico-culturale per la lingua tagalog. La paziente ha dichiarato di non aver mai eseguito test per l'epatite B nel Paese di origine e di non essere a conoscenza dello stato vaccinale del compagno, al quale è stato consigliato il dosaggio di HBsAg, anti-HBc e anti-HBs presso il medico curante.

> *Note metodologiche - Emocromo: analizzatore a citometria a flusso. HbA2/HbF: HPLC a scambio cationico; in presenza di carenza marziale l'HbA2 può risultare falsamente ridotta (esclusa in questo caso). Sierologia: immunodosaggi in chemiluminescenza; HBsAg reattivi confermati con neutralizzazione. HBV DNA: real-time PCR, intervallo lineare 10 - 1.000.000.000 UI/mL. Rischio combinato calcolato secondo l'algoritmo della Fetal Medicine Foundation.*

Prato, 12/10/2026

Il Dirigente Biologo
(chimica clinica, ematologia, sierologia)
Dott.ssa Serena Fantappiè

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente Medico
(microbiologia e virologia)
Dott. Duccio Bencini
Emoglobinopatie: Dott.ssa Ilaria Baldanzi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Verifica online - Dela Cruz M. - codice ritiro LAB-26-0418772: https://referti.uslbisenzio.example.it/v/LAB-26-0418772

AUSL VAL DI BISENZIO
LABORATORIO ANALISI
Dott. Niccolò Magherini
Ord. Biologi n. AA_061842
Visto per la trasmissione

(1) Gruppo sanguigno: la conferma su secondo campione è stata eseguita il 09.10.26 dalla TSLB I. Becagli.
(2) La paziente Dela Cruz è suscettibile alla toxoplasmosi: consegnate le norme igienico-alimentari; prossimo controllo prenotato con codice CUP-PO-26-551803.
(3) TSH e anti-TPO: si suggerisce valutazione endocrinologica entro 2 settimane per l'eventuale avvio di levotiroxina (comunicato al Dott. A. Biagini).
(4) Il compagno, sig. R. Bautista, è raggiungibile al +39 328 905 1174 ed è indicato dalla paziente come persona da contattare.